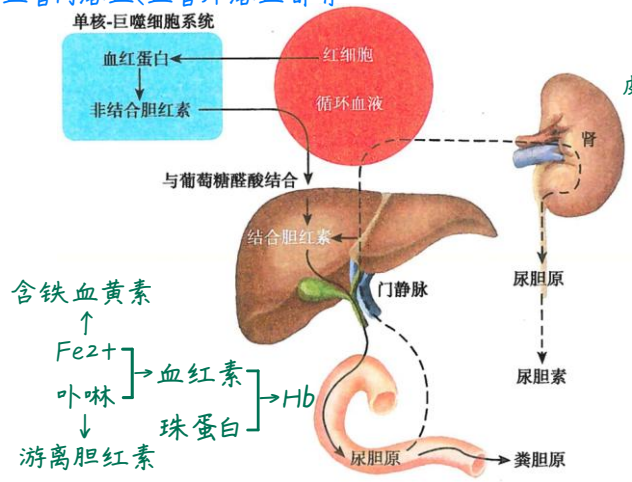
多多多多
TB=UCB+CB少

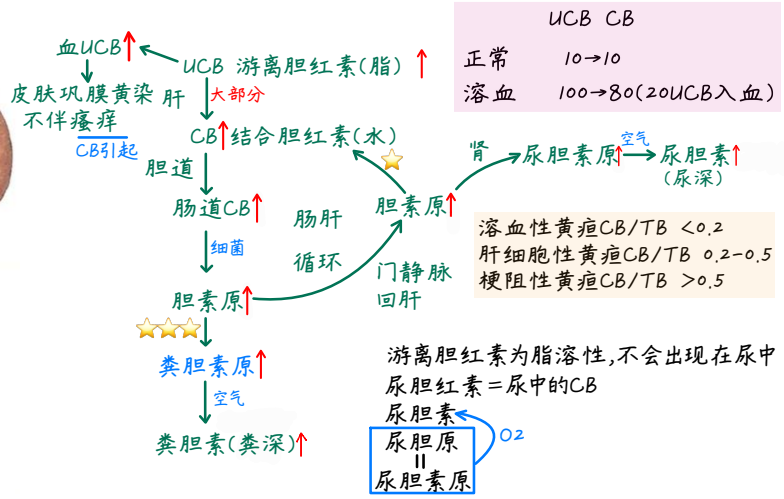
看尿中的CB=看血中的CB是否增加

4.**溶血性黄疸**：血 UCB↑、CB/TB＜0.2、胆素原↑（尿粪深）、**尿胆红素试验(-)**

血管内溶血、血管外溶血都有



单核巨噬细胞系统处理血红蛋白时
既会生成含铁血黄素
也会生成游离胆红素



四、溶贫的类型

（一）遗传性球形红细胞增多症 首选切脾

复习《生理学》：遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血） →遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂 （遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）正常RBC可以耐受更低的氯化钠
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245）

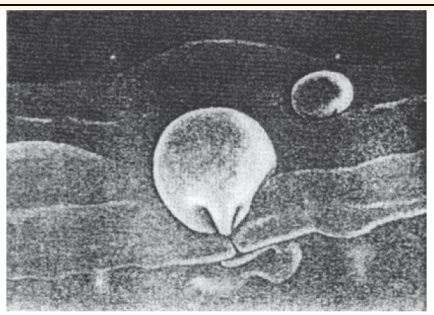
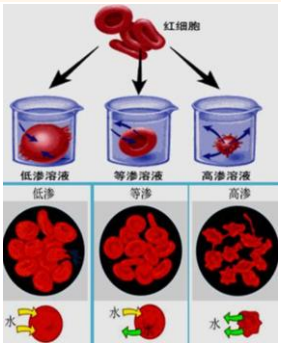


图 3-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙(大鼠)



1.表现

①**家族史** 主诉不要忽略

②常并发**胆囊结石** 血管外溶血→产生大量胆色素→形成胆结石

③外周**血涂片**：**球形细胞↑**、**渗透脆性↑**

小细胞高色素贫血



注意：血涂片球形细胞↑常见于遗传球、温抗体型自免溶

2.**切脾**（≥6 岁以避免**肺炎链球菌**感染的 OPSI）脾切除带来的问题
- 1.血栓问题
- 2.感染(要接种各种疫苗)

注意：切脾适合多数血管外溶血，而血管内溶血和原位溶血切脾无效
骨髓